

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE NIVELES DE CONCIENCIA EMOCIONAL (LEAS)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación del Desarrollo Cognitivo de la Conciencia Afectiva y Empatía

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Niveles de Conciencia Emocional (LEAS).
Nombre Original (Inglés)	<i>Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS)</i>
Autores Originales	Drs. Richard D. Lane, Donald R. Quinlan, Gary E. Schwartz et al. (1990), University of Arizona.
Adaptación Española	Barchard et al. (2010); adaptaciones y baremación clínica de Bados et al. y UCM.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Cognitivo-Evolutivo de la Conciencia Emocional (Lane & Schwartz).
Tipo de Instrumento	Prueba de rendimiento máximo basada en escenarios interpersonales con respuesta abierta narrativa.
Población y Rango	Adolescentes y adultos (≥ 14 años). Psiquiatría, neuropsicología, alexitimia y medicina psicosomática.
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos (versión 10 escenarios); 20 a 25 minutos (versión 20 escenarios).
Régimen de Licencia	Instrumento científico abierto para uso clínico y de investigación con acreditación de fuentes.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO COGNITIVO-EVOLUTIVO DE LANE

La LEAS fue formulada por Richard D. Lane y Gary E. Schwartz partiendo de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, trasladada a la conceptualización del procesamiento afectivo. Postula que la **conciencia emocional** es una capacidad cognitiva estructural de orden superior que experimenta una diferenciación jerárquica progresiva: desde representaciones implícitas somatovegetativas hasta conceptos verbales abstractos, complejos y multidimensionales.

A nivel neurobiológico, la escala captura la maduración y conectividad funcional entre la corteza cingulada anterior rostral (rACC), el córtex prefrontal ventromedial y el córtex insular anterior. Estas áreas permiten transformar los estados de activación autonómica subcortical (amígdala y tronco cerebral) en representaciones simbólicas conscientes. La incapacidad para acceder a niveles simbólicos superiores (alexitimia estructural) predispone a somatizaciones viscerales masivas, impulsividad motora desregulada e incapacidad para la empatía relacional.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y JERARQUÍA DE NIVELES EMOCIONALES

Nivel de Conciencia	Puntos	Estadio	Manifestación Operativa y Fenomenológica Evaluada
Nivel 0: Sin Afecto	0 puntos	Pre-emocional	Respuestas sin contenido afectivo; descripciones fácticas, cogniciones o conductas ("pensaría qué hacer").
Nivel 1: Somatosensorial	1 punto	Sensoriomotor	Sensaciones viscerales o corporales indiferenciadas ("sentiría náuseas, dolor en el pecho, taquicardia").
Nivel 2: Acción / Global	2 puntos	Acción motora	Tendencias conductuales o estados globales indiferenciados ("me sentiría mal", "tendría ganas de romper algo").
Nivel 3: Emoción Básica	3 puntos	Operaciones conc.	Uso de palabras emocionales primarias unívocas y bien delimitadas ("sentiría alegría", "sentiría ira", "tristeza").
Nivel 4: Mezcla Compleja	4 puntos	Operaciones form.	Presencia de dos o más emociones simultáneas o ambivalentes ("sentiría orgullo por el logro pero culpa por él").
Nivel 5: Diferenciación	5 puntos	Integración social	Diferenciación mutua sofisticada entre la experiencia compleja de Uno Mismo (Yo) y la del Otro.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente homogeneidad: alfa de Cronbach de 0.81 a 0.88 en adaptaciones hispanohablantes para la versión de 10 y 20 escenarios (Barchard et al., 2010; Lane et al., 1990).
Fiabilidad Interjueces	Concordancia entre evaluadores clínicos altamente entrenados con coeficientes de correlación intraclase (CCI) superiores a 0.88 - 0.94.
Validez Concurrente y Divergente	Correlación inversa significativa con medidas de autoinforme de alexitimia (TAS-20, $r = -0.52$); correlación positiva con pruebas de empatía (IRI), Teoría de la Mente (RMET) y apertura mental.
Validez Discriminante Máxima	A diferencia de los autoinformes (que miden creencias sobre las propias emociones), la LEAS mide habilidad cognitiva real demostrada mediante rendimiento verbal.
Sensibilidad Neuropsicológica	Detecta déficits estructurales de mentalización en lesiones de la corteza prefrontal ventromedial, esquizofrenia, autismo y trastornos graves de la personalidad.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Para cada uno de los escenarios interpersonales propuestos en el protocolo, se aplican las siguientes directrices de corrección estandarizada:

- **1. Puntuación del Yo (Self Score):** Se asigna de **0 a 4 puntos** en función del nivel máximo de conciencia emocional expresado para uno mismo.
- **2. Puntuación del Otro (Other Score):** Se asigna de **0 a 4 puntos** en función del nivel máximo de conciencia emocional atribuido al otro personaje.
- **3. Puntuación Total del Escenario:** Es el valor máximo entre la puntuación del Yo y la del Otro, con **una excepción esencial:** si tanto el Yo como el Otro alcanzan el Nivel 4 (emociones complejas) y dichas emociones son cualitativamente distintas entre sí, el escenario recibe **5 puntos** (Nivel 5 de diferenciación social).
- **Puntuación Total LEAS-10:** Suma de las puntuaciones totales de los 10 escenarios (Rango: **0 a 50 puntos**).

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (LEAS-10)

Nivel LEAS	Rango Total	Estadio Predominante	Significación Clínica y Terapéutica
Bajo / Alexitímico	0 a 24	Sensoriomotor / Acción (Niveles 1–2)	Incapacidad para nombrar afectos; somatización, quejas viscerales y acting-out impulsivo. Psicoeducación emocional.
Medio Básico	25 a 34	Emociones Básicas Unívocas (Nivel 3)	Reconoce tristeza, ira o alegría simples, pero le cuesta integrar la ambivalencia o emociones mixtas complejas.
Alto / Complejo	35 a 44	Diferenciación y Mezcla (Nivel 4)	Buena captación de matices afectivos y empatía hacia los demás. Nivel adaptativo maduro.
Superior	45 a 50	Integración Social Óptima (Nivel 5)	Excelente sofisticación mentalizadora. Diferenciación precisa entre vivencias propias y ajenas.

ALEXITIMIA ESTRUCTURAL FRENTE A DEFENSIVA (LEAS < 25):

Un puntaje global en el LEAS-10 < **25 puntos** confirma la presencia de una alexitimia por déficit neurocognitivo estructural (incapacidad de mentalizar el afecto). En estos pacientes, los abordajes interpretativos o introspectivos fracasan; es mandatorio utilizar técnicas de rotulación emocional guiada, biblioterapia y entrenamiento en vocabulario afectivo.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN ENTRENAMIENTO DE CONCIENCIA AFECTIVA

PROTOCOLO DE ANDAMIAJE COGNITIVO SEGÚN EL ESTADIO LEAS:

- **Si predominan Niveles 1 y 2 (LEAS < 25):** Intervención de primer escalón: mapeo corporal somatotópico (conectar nudo en la garganta con tristeza, opresión torácica con miedo). Prohibir respuestas de acción motora ("pegaría un puñetazo") y forzar la traducción a etiquetas verbales primarias.
- **Si predomina Nivel 3 (LEAS 25 a 34):** Intervención de segundo escalón: entrenamiento en ambivalencia emocional (ej. "¿Es posible sentirse triste por perder un trabajo pero aliviado por no madrugar?"). Fomentar el uso de conjunciones "y" en vez de "pero".
- **Si predomina Nivel 4 (LEAS 35 a 44):** Entrenamiento en mentalización interpersonal (Teoría de la Mente): diferenciar proyecciones propias de los sentimientos genuinos del otro.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN TRASTORNO SOMATOMORFO Y ALEXITIMIA

Paciente: Varón de 35 años, mecánico de automoción, derivado por medicina interna tras múltiples ingresos por cólicos abdominales intensos y cefaleas sin hallazgos orgánicos. En la entrevista, insiste en que «a nivel emocional no le pasa nada» y que solo quiere «que le quiten los dolores».

Evaluación Cuantitativa Inicial LEAS-10: Puntuación Total = **14 / 50 puntos** (Media por escenario = 1.4; Nivel Alexitímico Severo).

• **Análisis de Respuestas por Escenario:** En el escenario de infidelidad de un amigo, responde para el Yo: «Sentiría un dolor punzante en la tripa y me darían ganas de partírla la cara» (Nivel 1 y 2). Para el Otro: «Pensaría que es un traidor» (Nivel 0, pensamiento). Puntuación del escenario = 2 puntos.

Formulación Clínica: Alexitimia estructural con detención evolutiva en el estadio sensoriomotor. El paciente procesa el dolor psíquico exclusivamente a través de descargas neurovegetativas viscerales (somatización gástrica) e impulsos motores agresivos.

Tratamiento y Evolución: Terapia Focalizada en la Mentalización (MBT) individual de 16 sesiones: entrenamiento sistemático en identificación de emociones básicas y elaboración de diarios afectivos guiados. Al mes 5, el LEAS ascendió a **32 puntos** (alcanzando el Nivel 3 consolidado), logrando nombrar la tristeza y la decepción, con remisión del 80% de los episodios de dolor abdominal.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN

DISTINCIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y VERBORREA

Cuidado con respuestas extensas pero vacías de términos emocionales (ej. descripciones minuciosas de la escena sin palabras afectivas). Pertenecen estrictamente al Nivel 0 (cognitivo/fáctico). Calificar solo la presencia de vocabulario emocional genuino.

CRITERIO ESTRICTO PARA NIVEL 5 (5 PUNTOS)

Para otorgar 5 puntos en un escenario, el Yo debe tener Nivel 4, el Otro debe tener Nivel 4 y ambas emociones deben ser distintas e independientes (ej. Yo: triste y aliviado; Otro: culpable y asustado).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Lane, R. D., Quinlan, D. M., Schwartz, G. E., Walker, P. A., & Zeitlin, S. B. (1990). The Levels of Emotional Awareness Scale: A cognitive-developmental measure of emotion. *Journal of Personality Assessment*, 55(1-2), 124–134.
2. Barchard, K. A., Bajgar, J., Leaf, D. E., & Lane, R. D. (2010). Computer scoring of text for levels of emotional awareness. *Behavior Research Methods*, 42(2), 586–597.
3. Lane, R. D., & Schwartz, G. E. (1987). Levels of emotional awareness: a cognitive-developmental theory and its application to psychopathology. *American Journal of Psychiatry*, 144(2), 133–143.
4. Subic-Wrana, C., Beutel, M. E., Knebel, A., & Lane, R. D. (2010). Theory of mind and levels of emotional awareness. *Psychopathology*, 43(6), 365–372.